

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic look.

Candida et candidoses

► I) Définition:

Les candidoses sont des mycoses cosmopolites provoquées par des champignons **levuriformes** (levures) **commensaux** appartenant au genre *Candida*

l'espèce la plus courante est *Candida albicans*.

les aspects cliniques sont nombreux et de gravité variable.

Emergence de nouvelles especes

Candida africana .

Candida haemulonii.

Candida auris

- *Candida albicans*: espèce la plus fréquente commensale des muqueuses digestives et génitales.

Candida non albicans:

espèces les plus fréquentes:

- *C.glabrata*: écologie proche de celle de *C.albicans*
- *C.parapsilosis*: levure fréquente de la peau mais pas du tube digestif.
- *C.tropicalis*: milieu extérieur(le sol, l'eau, les céréales)
- *C.krusei*: milieu extérieur, peut se retrouver accidentellement dans le tube digestif suite à son ingestion.

Les aspects cliniques des candidoses sont nombreux et variés, classés en deux groupes, les candidoses superficielles et les candidoses profondes, qui diffèrent par leur localisations, leur gravité, leurs facteurs de risque et les espèces en cause.

	Candidoses superficielles	Candidoses profondes
Organes cibles	Muqueuses, peau, ongles	Sang et organes profonds
Espèces en cause	C.albicans >95%	-C.albicans 50% -C.non albicans 50% (C.glabrata, C.tropicalis, C.parapsilosis, C.krusei)
Patients à risque	-immunocompétents (facteurs locaux « 1 » et généraux « 2 »); -immunodéprimés « 3 ».	-immunodéprimés (neutropénie) « 4 »; -chirurgie (digestive surtout); -patients porteurs de voies veineuses ou autre matériel étranger « 5 ».
pronostic	bon	Grave Mortalité 40% (fongémies)

Candidoses superficielles:

elles sont très fréquentes, en majorité bénignes, faciles à diagnostiquer et à traiter. L'identification des facteurs de risque est importante pour éviter les récives.

a) Candidoses digestives:

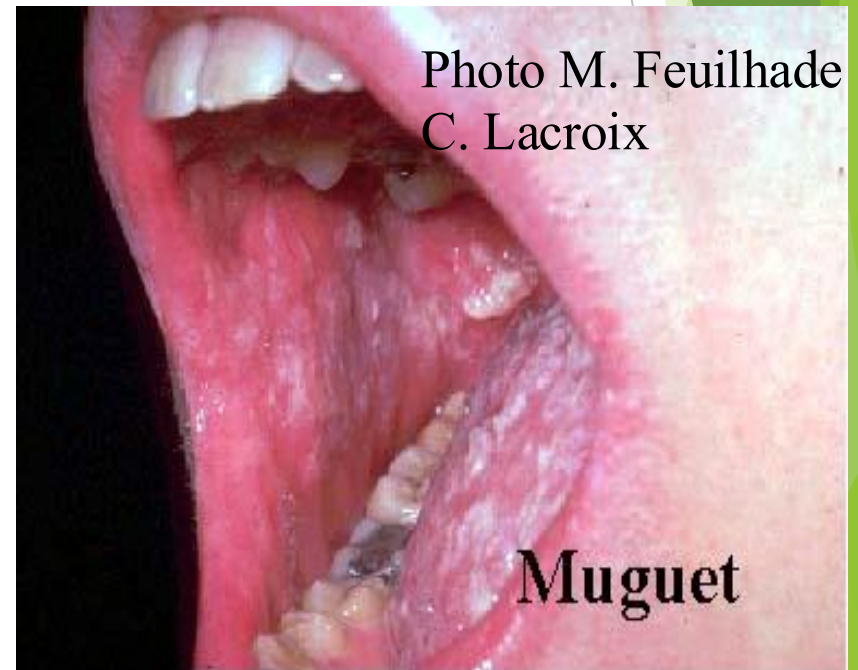
candidoses buccales:

❖ signes majeurs: érythème puis dépôts blanchâtre traduisant la prolifération des levures.

signes fonctionnels modérés: bouche sèche, sensation de gout métallique, brûlures buccales avec ou sans douleur à la déglutition.

❖ Formes cliniques:

-**muguet buccal**: dépôts blanchâtres sur la langue, la gencive, la face interne des joues, le voile du palais et le pharynx. Muqueuse sous-jacente érythémateuse.



-**glossite**: langue érythémateuse, luisante, lisse, dépapillée et douloureuse. Pas de dépôts blanchâtres.



- **perlèche**: fissuration bilatérale de la commissure des lèvres gênant l'ouverture de la bouche.

souvent associée à une atteinte buccale interne.



⇒ Prélèvements des lésions buccales: frottis des lésions.

◦ candidose œsophagienne:

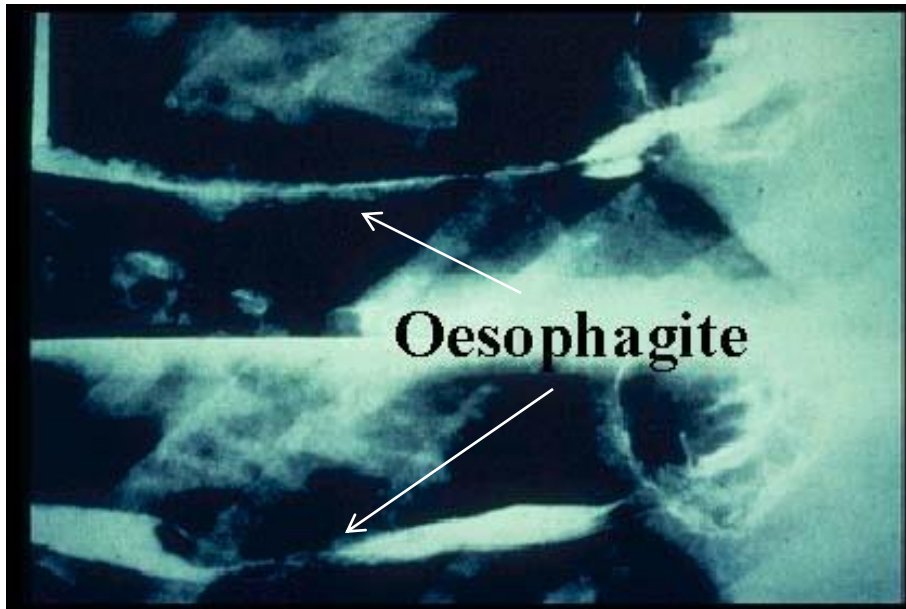
- facteur de risque: immunosuppression lymphocytaire T (VIH, cancer).

signes cliniques: douleur à la déglutition et brûlures œsophagiennes (pyrosis)

augmentées au passage des aliments.

Candidose buccale souvent associée.

- fibroscopie: enduit blanchâtre caractéristique avec ou sans ulcérations.



⇒ Prélèvements:

- prélèvement buccal si lésions buccales associées;
- fibroscopie et biopsie des lésions œsophagiennes si absence de candidose buccale;
- et rechercher une immunosuppression sous-jacente.

Candidose gastro-intestinale:

- Candidoses gastriques: secondaires aux candidoses buccales ou œsophagienne accompagnées de brûlures gastriques, de vomissements douloureux.
- Candidoses intestinales:
 - * l'atteinte du grêle est exceptionnelle. Elle réalise un tableau de gastro-entérite aiguë.
 - * l'atteinte colique se manifeste par des douleurs abdominales diffuses spontanées.

O Candidose anale:

c'est au départ une anite entrainant un prurit intense au passage des selles.

l'infection s'étend ensuite localement vers les plis (intertrigo périanal) et, chez le nourrisson, vers le siège (érythème fessier du nourrisson)



Il faut y penser chez un patient adulte qui présente un prurit anal violent après une prise d'antibiotiques. A noter que cette atteinte à *Candida* peut aussi révéler un diabète.

⇒ prélèvements: frottis d'anus, frottis ou grattage des lésions des plis.



- o la laryngite à *Candida* succède habituellement à un muguet pharyngé qui se manifeste par une dysphonie et parfois une aphonie.
- O La bronchite à *Candida* simule cliniquement une bronchite mucopurulante fébrile. La toux fréquente, s'accompagne parfois d'hémoptysies.
- O La candidose de l'oreille: elle réalise une otite.

b) Candidoses génitales:

O Vaginite:

fréquente (75% des femmes) et récidivante (1 fois sur 4).

signes cliniques: leucorrhées blanchâtres abondantes et prurit vulvaire intense.

Examen au spéculum: muqueuse érythémateuse et œdémateuse recouverte d'un enduit blanchâtre caractéristique.

C) Candidoses cutanées et unguéales:

O Intertrigo=atteinte des plis:

caractérisé par un érythème suintant avec enduit blanchâtre au fond du pli souvent crevassé.

les lésions sont prurigineuses, se surinfectent et s'eczématisent facilement.

★intertrigo des grands plis inguinaux, abdominaux, sous-mammaire, interfessier...

- Facteur de risque: obésité (favorise l'humidité et la macération des plis, mais peut se voir aussi chez les diabétiques).



- ★ intertrigo des petits plis: espaces interdigitaux palmaire (mains) et plantaires (pieds).
prélèvements: frottis des dépôts blanchâtres, grattage des squames en bordure de lésion.



O atteinte des ongles:

touche surtout les mains: on la rencontre typiquement chez les sujets qui sont amenés à immerger les mains dans l'eau de façon fréquente: ménagères, plongeurs dans les restaurants, coiffeurs....

★ **onyxis**: atteinte de l'ongle. Débute au bord proximal de l'ongle et s'étend vers le bord libre de l'angle qui devient jaunâtre et se détache de son lit.

★Périonyxis= tuméfaction rouge douloureuse entourant la base de l'ongle.



péri



Photo M. Miégevill

Onyxis et périonyxis

Candidoses profondes:

les candidémies (isolement de *Candida* dans une hémoculture) représentent actuellement la 4^{ème} septicémie en milieu hospitalier et elles représentent environ 10% des infections sanguines nosocomiales.

C.albicans est isolé dans 50% des cas.

➤ Facteurs de risque des candidémies:

- neutropénie de durée >7 jours.
- KT central (surtout si >14 jours):communication directe entre la flore cutanée et l'espace vasculaire.
- antécédents de chimiothérapie(altère la capacité de phagocytose, ulcérations au niveau du tube digestif), radiothérapie (↓ des défenses immunitaires locales au niveau des muqueuses) ou corticothérapie.
- antibiothérapie à large spectre.
- colonisation digestive haute ou basse par *Candida sp.*
- chirurgie abdominale récente: perforation digestive (réservoir digestif important des levures.
- hémodialyse
- nutrition parentérale totale
- hospitalisation prolongée en réa ou en unité de greffe de moelle.

Diagnostic:

Diagnostic des candidoses superficielles:

il se déroule en plusieurs étapes.

prélèvements

Examen direct:

Mise en culture

Identification de l'espèce



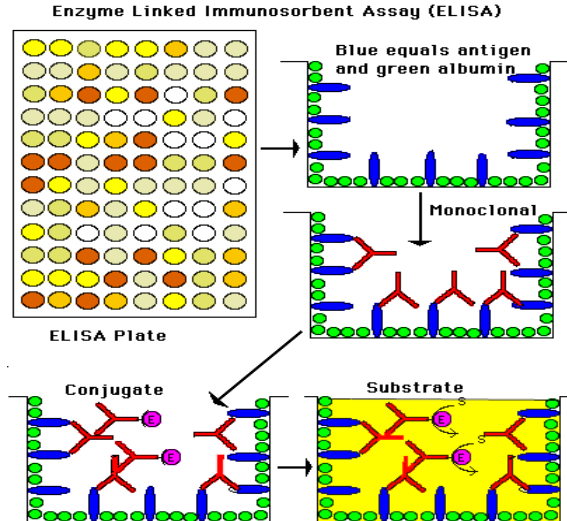
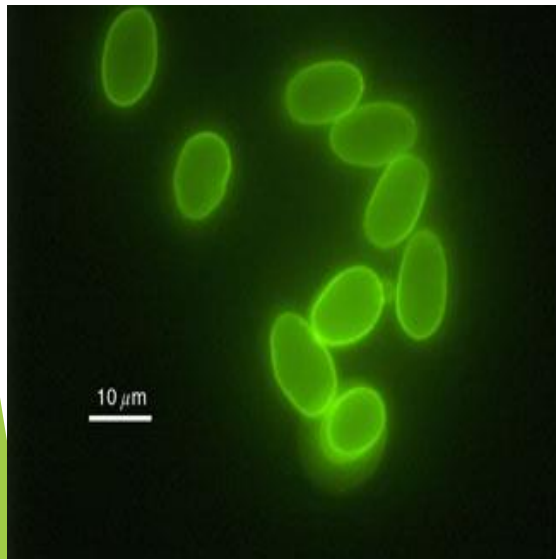


Chlamydospores de *C.*
albicans

Diagnostic indirect:

★Détection d'anticorps spécifiques:

-le dépistage d'une candidose systémique doit associer deux techniques parmi les suivantes: électrosynérèse, hémagglutination indirecte, ELISA, IFI. Si un des tests est positif, les tests de confirmation coélectrosynérèse, immunoélectrophorèse(technique de référence) sont à réaliser.



Conclusion :

Les candidoses, mycoses opportunistes émergentes, constituent actuellement un problème de santé publique, en rapport avec :

- La gravité de plus en plus marquée.
- L'augmentation continue de leur incidence.
- L'apparition de nouvelles espèces plus virulente.
- Le développement des résistances vis-à-vis des antifongiques habituels.

D'où la nécessité de **nouvelles techniques de diagnostic plus fiables et rapides**, l'établissement **d'un système de surveillance des profils de sensibilités aux antifongiques**, et la recherche de **nouvelles cibles thérapeutiques**.